2.治疗（类似预激综合征伴顺向型房室折返性心动过速 AVRT）

①刺激迷走神经（抑制房室结传导）终止发作，无效**首选腺苷**，次选维拉帕米、地尔硫卓，**有收缩性心衰用强心苷**

②伴血流动力学障碍用电复律，但**已用强心苷者禁止电复律**（水火不相容）电复律让窦房结重新发生冲动，强心苷让房室结处于抑制状态

③其它可选用的如~~普罗帕酮~~、胺碘酮、β-R 拮抗剂、某些升压药（去氧肾上腺素/苯肾上腺素、间羟胺、甲氧明）

④根治：**导管消融**（可致心脏压塞）患者本身合并低血压，既升压又反射性兴奋迷走N

心律失常可能会与心包积液一起考　现在面对低血压直接电复律

3.心电图

①**突发突止**（不必预防用药）①适时的房早，刚好处于快路径的不应期，才能使其被迫走慢路径进而引起折返 ②只要打破了折返就会终止：如刺激迷走神经、房早本身

②心率多 150-200 次/分、偶尔＞250 次/分、尤其儿童（《诊断学》10 版教材 P480：一般 160-250 次/分）

③**心律绝对规则**（不同 RR 间距几乎完全均匀）折返环　固定的折返环

④可见**逆行 P'波或无 P 波**（逆行 P'波常埋藏于 QRS 波内或位于其终末）

⑤**QRS 波形态多正常（除非发生室内差异性传导）**激动心室会相对来说快一点（房室结后是希氏束、浦肯野纤维，传的快）



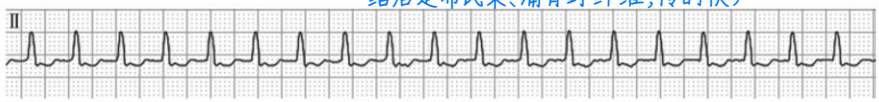
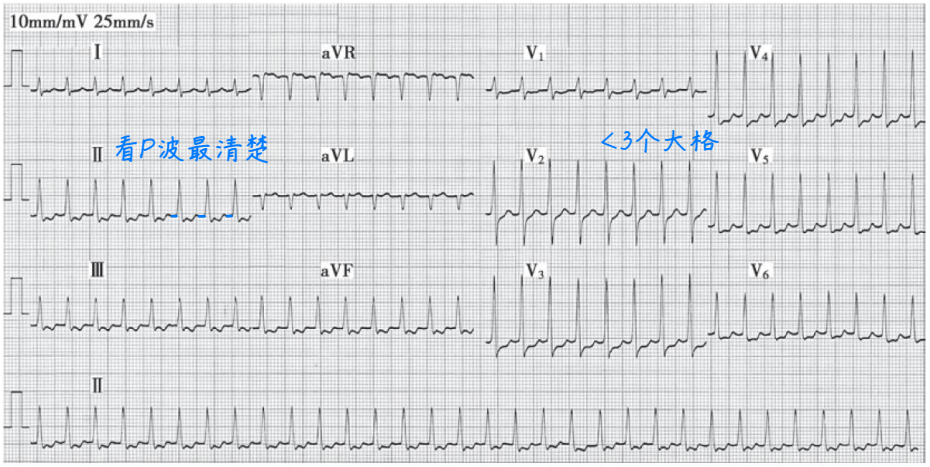


图 3-3-15　房室结折返性心动过速　RR间期绝对规则+逆行P'波/无P波

连续快速、规则的 QRS 波群，其形态和时限均正常，频率 154 次/分，QRS 波群终末部分可见逆行 P 波。



心室率=300/RR间距

图 5-1-64　室上性心动过速

